



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : رضا عبد الجواد سيد عبد القادر

المحافظة : الجيزة

العنوان : اطيح

رقم البطاقة : 28710142102989 رقم التليفون : 01223799010

تاريخ تسجيل الإستمارة : 03-10-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 14-10-1987 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني الوظيفة: التوقيع:
الاسم: د/ندى حسن الوظيفة: التوقيع:
الاسم: د/نرمين رمضان الوظيفة: التوقيع:
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د/..... د/..... د/..... د/.....

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: رضا عبد الجواد سيد عبد القادر National ID: 28710142102989	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

٢٠٢٧/١١ ٢٩٨٩-٢١٠٢٩٨٩
 رتبة منزل

أشقي
 محمد كمال محمد عبد القادر سليم
 البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/١١/٢٩

جهاز تنظيم الممارسات
 طباعة بطاقات الترخيص

رضا
 عبدالجواد محمد عبدالقادر
 قرية الزبدية
 مركز الطنج - الجيزة

٢٩٨٩-٢١٠٢٩٨٩

٢٨٧١٠١٤٢١٠٢٩٨٩

١٧٣٥
 زو عا ر ك س
 ن س س
 م ق ل ا م س
 م ا م و ج ا م



٢٠٢٢/١١ ٢٨٧١٠١٤٢١٠٢٩٨٩

رية منزل

مترجحة

مسلمة

التي محمد عبد القادر سليم

البلدية سارية حتى ٢٠٢٩/١١/١٤



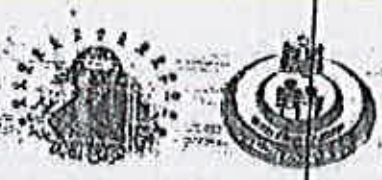
٢٨٧١٠١٤٢١٠٢٩٨٩

JQ8498280

محمد بن زكريا بن محمد بن زكريا
مطابق لفتح السجلية

ارضا
عبدالمجيد بن عبد القادر
قرية الزويت
مركز القليوب - الجيزة

Name: رضا عبد الجواد سيد		GUSTAVE ROUSSY	
MR. : 4084			
Detailed Medical Report			
			السيد
تخية طبية وبعد,,			
		إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
		رقم طبي:	بقسم:
ننشر بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته			
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه			
Adjuvant hormonal treatment: AI + Zoladex + Zometa, Femara by examination: CX lymph node for neck US. Patient came today for Femara, Zoladex 10.8 mg, supplemental treatment for 3 months. Pharmacy: weight 89 kg, serum creatinine 0.5 mg/dL, calcium 1.23 mmol/L, Zometa + Femara + Zoladex. Premenopausal left breast cancer, left MRM 21/8/2022, T1 N3, 18/26 IDC, ER 8/8, PR 8/8, HER2-negative, Ki-67 10%, recurrence 4, AC 4, TXT port, st Zoladex Femara from 18/4/2023 for new SM CT chest pause (CC dyspnea) for Zometa Femara. Zoladex due date 3/7/2026. Femara + supplemental treatment >> 3 M Zoladex today, annual assessment pending next visit after 3 months.			
تحريرا في ,			
		التاريخ : 21-09-2026	الوقت :
		نهي سعيد علي محمد	الطبيب المعالج :
يعتمد ,			



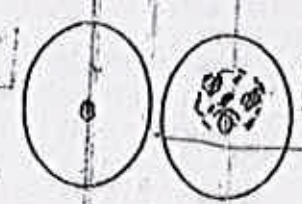
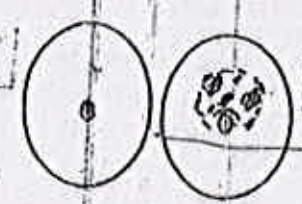
إدارة رئيس الجمهورية
لصحة المرأة المقيمة

السلطة الفلسطينية
152

MDT FORM

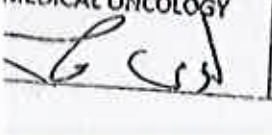
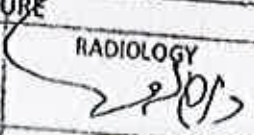
8/18/2022

Name	د. عبد الجواد عبد القادر	MRN	SAV/1491.5419
Age	84	ID	222
Menopausal status		Phone	012 23 799 010
OCP		marital status	
Co morbidity	invalment	Family history	invalment

Bx:	I.D.C	Clinical Data	
ER:	8/8	PR:	8/8
HER2:	-ve	KI67:	10%
Sonomammography:		R	
lt. breast mass and small satellites as described by signal pattern.			
Mets Workup:		L	
free, bone scan free			
Recommendations:		CT, N, M, no fracture	

MDT OUTCOME & PLAN

for up front
of MRM/Skin/nipple sparing mastectomy + TRAM

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	SIGNATURE	RADIOLOGY	PATHOLOGY
				

Request No. : 13007685
Request Date : 12/08/2023
Verification Date : 15/08/2023
Financial Category : اورام دار السلام - نفقة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Printing By : marwa mohamed youss

Patient Name : الأستاذة / رضا عبدالجواد سعيد عبدالقادر	Request No. : 13006742
Patient No. : 28710142102989	Request Date : 21/08/2022
Path No. : 2421/22	Verification Date : 29/08/2022
Sex : Female	Financial Category : أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age : 34 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : Ali mostafa

Pathology Report

- Multicentric Invasive lobular carcinoma GII, with high grade lobular carcinoma in situ.
- Positive metastatic deposits in (18/26) LNs, with extracapsular infiltration.
- Free deep margin, nipple & areola.
- Stage: pT1, pN3

Prof. Dr. Gamal Abdelaty
Dr. Abdulrahman Ibrahim

Verified by :
abdelrahman ibrahim

Patient Name: Reda Abd Al Gawwad Abd Al Kader	Date : 20/08/2022
Exam : C.T. ABDOMEN & PELVIS WITH CONTRAST	Age : 34 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 13853

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:-

- Left breast multiple spiculated lesions largest seen in the UOQ measures 1.7 x 2 cm.
- Enlarged level I, II and III left axillary lymph nodes largest measures 1 x 1.5 cm.
- Left lower lung lobe basal segment pleural based 5 mm nodule. No other sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitory lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.



Patient Name: Reda Abd Al Gawwad Sayed Abd Al Kader	Date : 20/04/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 37 Year(s)
Medical ID: 2337/2022	Pat. ID: 13853

RIGHT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL US

Indication:

Patient had left MRM In

Technique

- right breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Report:

- The right breast is scattered fibroglandular densities of the right breast (ACR B)
- Left mastectomy bed with muscle flap showing two areas of macrocalcifications ? fat necrosis
- No spiculated masses or grouped microcalcifications.
- Complementary ultrasound also showed:
- Left mastectomy showing :
 - Two areas of mixed echogenicity and internal cystic changes seen at 2-3 o'clock measured about 4x3x1.5 cm and another one at 12-1 o'clock measured 1.5x1 cm
- Free left Infra and supra clavicular regions.
- Right breast:
- No right breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness and nipple-areola complex, with average caliber of the retro-areolar ducts
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left operative bed with no evidence of recurrent mass lesions

Opinion:

- Left mastectomy bed with muscle flap showing two areas of fat necrosis with overlying dystrophic calcification for follow up after 6 months BIRADS3
- No right breast suspicious findings (BIRADS 2)

Dr, Basma Mohamed

13-05-2024

Dynamic Contrast Enhanced MRI Study of the Breast :

Pulse Sequences :

Pre-contrast axial T1,T2 ,STIR and Sagittal T2WIs.

Post-contrast axial VIBE and Subtraction WIs.

Indication of the examination:

36 years old female patient known left breast cancer post left reconstruction

Report:

- Status post left reconstruction showing post-operative changes no residual /recurrent masses.
- Left breast axillary tail at site of reconstruction two mass lesions largest measuring 3.5 x 2.5 cm being high in T1WI, low in T2WI , and suppressed in fat sat images with no diffusion restriction, with peripheral enhancement representing area of fat necrosis.
- Normal right breast.
- Normal skin thickness of the right breast
- Normal nipple areola complex of right breast.
- No pathological enlarged axillary lymph nodes.

OPINION:

- 36 years old female post left reconstruction, no residual /recurrent masses with two areas of fat necrosis as described. (BIRADS II).
- Normal right breast (BIRADS I).

DR. HEBA NABIL, M.D

Women imaging Consultant

Dynamic Contrast Enhanced MRI Study of the Breast :

Pulse Sequences :

Pre-contrast axial T1, T2, STIR and Sagittal T2WIs.

Post-contrast axial VIBE and Subtraction WIs.

Indication of the examination:

36 years old female patient known left breast cancer post left reconstruction

Report:

- Status post left reconstruction showing post operative changes no residual /recurrent masses.
- Normal right breast.
- Normal skin thickness of the right breast
- Normal nipple areola complex of right breast.
- No pathological enlarged axillary lymph nodes.

OPINION:

- 36 years old female post left reconstruction, no residual /recurrent masses. (BIRADS II).
- Normal right breast (BIRADS I).

DR. HEBA NABIL, M.D
Women imaging Consultant